arGLP-1 y cáncer relacionado con la obesidad: el resultado depende de contra qué los comparas

Hernández-Pérez JG, Abdelgadir O, Torres-Sánchez L, Chen J, Almandoz JP, Cowell LG, Messiah SE, Lopez DS. GLP-1 receptor agonists and obesity-related cancer by diabetes severity. *JAMA Netw Open*. 2026;9(11):e2641869. doi:10.1001/jamanetworkopen.2026.41869

Versión 1.0 · Revisado el 9 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo (carta de investigación)

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

No

Tranquiliza sobre el conjunto de cánceres relacionados con la obesidad a 3–5 años, pero los propios autores advierten que no sirve para elegir el antidiabético para prevenir cáncer.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?

Buen diseño, un solo centro

Comparador activo y usuarios nuevos, pero retrospectivo, con expedientes electrónicos de un solo sistema de salud y seguimiento corto para cáncer.

CUIDADO AL INTERPRETAR

¿Contra quién?

Hubo menos cáncer que con insulina (que suele iniciarse en enfermedad más avanzada) y que con sulfonilureas, pero no significativamente menos que con metformina, iSGLT2 ni iDPP4.

En 30 segundos. Con expedientes electrónicos de un centro académico de Dallas (población de origen de 359,595 adultos, 2010–2025), los autores emularon cinco "ensayos": adultos con DM2 y sin cáncer previo que **iniciaron un arGLP-1** frente a quienes iniciaron metformina, insulina, un iSGLT2, un iDPP4 o una sulfonilurea, balanceados con ponderación por puntaje de propensión. El desenlace fue el primer diagnóstico de un cáncer relacionado con la obesidad. A 3 años hubo **menos cáncer que con insulina** (2.0 vs. 3.3 %; diferencia −1.25 puntos; HR 0.62) y **que con sulfonilureas** (2.9 vs. 4.0 %; −1.14 puntos; HR 0.67). Frente a **metformina, iSGLT2 e iDPP4 no hubo diferencia significativa** (estimaciones cercanas al nulo, con IC amplios). A 5 años se mantuvo frente a insulina; frente a sulfonilureas el HR siguió bajo (0.75), pero la diferencia absoluta ya no fue significativa.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

El comparador define la pregunta: qué es la emulación de un ensayo objetivo con usuarios nuevos y comparador activo, por qué "menos cáncer que con insulina" no es lo mismo que "previene el cáncer", y por qué conviene leer la diferencia absoluta junto al HR. Además: decenas de estimaciones sin ajuste por comparaciones múltiples.

1 La pregunta clínica (PICO)

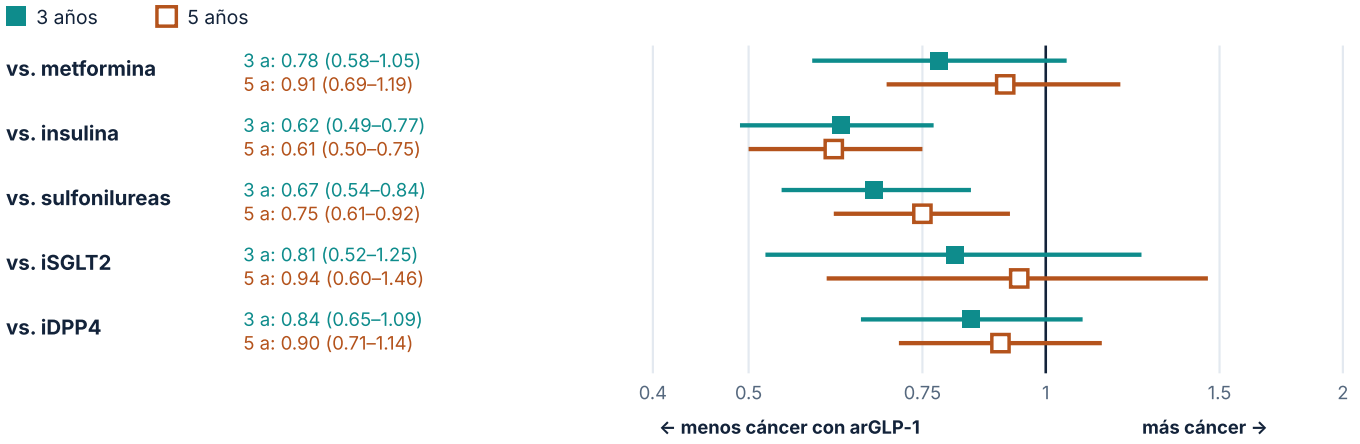
P · POBLACIÓN	Adultos con DM2 sin cáncer relacionado con la obesidad previo, atendidos en UT Southwestern (red PCORnet) entre 2010 y 2025, que iniciaron un antidiabético tras 365 días sin usarlo. Gravedad de la DM2 por la complicación más grave previa: alta (enfermedad macrovascular o ERC 4–5), moderada (complicaciones microvasculares o ERC 1–3) o baja (ninguna).
I · EXPOSICIÓN	Iniciar un arGLP-1 (el artículo no los separa por fármaco ni dosis).
C · COMPARADORES	Iniciar metformina, insulina, iSGLT2, iDPP4 o sulfonilurea; un "ensayo" por separado para cada uno.
O · DESENLACE	Primer diagnóstico de cáncer relacionado con la obesidad en el expediente, a 3 y a 5 años (riesgo absoluto, diferencia de riesgo y HR).

2 Diseño

TIPO	Cohorte retrospectiva analizada como **emulación de ensayo objetivo**, con usuarios nuevos y comparador activo (sigue las guías STROBE y TARGET). Publicada como carta de investigación; el detalle de los métodos está en el suplemento.
ANÁLISIS	Puntaje de propensión estimado por separado para cada comparador y cada estrato de gravedad; pesos estabilizados truncados en el percentil 99. Riesgos y diferencias por regresión logística ponderada (IC por *bootstrap*) y HR por Cox ponderado. Casos completos. Sin ajuste por comparaciones múltiples; los análisis por gravedad son exploratorios.
SEGUIMIENTO	Desde el inicio del fármaco hasta el cáncer, la muerte, la última consulta registrada, el 31 de julio de 2025 o los 3 o 5 años.
FINANCIAMIENTO	NIH, Instituto Nacional del Cáncer, CPRIT y Texas Pharmaceutical Initiative (Texas) y PCORI; los financiadores no participaron en el diseño ni en el análisis. Uno de los autores declaró honorarios de varias farmacéuticas, entre ellas fabricantes de arGLP-1 y de algunos comparadores.
AUTORES	UT Southwestern (Dallas); dos de los autores están afiliados también al Instituto Nacional de Salud Pública de México (Cuernavaca).

3 Resultados

Iniciar arGLP-1 frente a cada comparador: HR de cáncer relacionado con obesidad



Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de las tablas 1 y 2 del artículo (análisis de todos los pacientes). No reproduce figuras originales.

COMPARADOR	RIESGO A 3 AÑOS (ARGLP-1 VS. COMPARADOR)	DIFERENCIA A 3 AÑOS (PUNTOS)	DIFERENCIA A 5 AÑOS (PUNTOS)
Metformina	3.0 vs. 3.6 %	−0.56 (−1.25 a 0.26)	0.33 (−1.23 a 2.01)
Insulina	2.0 vs. 3.3 %	**−1.25 (−1.74 a −0.83)**	**−1.67 (−2.36 a −1.11)**
Sulfonilureas	2.9 vs. 4.0 %	**−1.14 (−1.85 a −0.51)**	−0.72 (−1.83 a 0.31)
iSGLT2	2.8 vs. 2.7 %	0.06 (−1.33 a 1.29)	1.05 (−0.63 a 2.43)
iDPP4	2.8 vs. 3.2 %	−0.39 (−1.30 a 0.35)	−0.02 (−1.23 a 1.15)

Diferencias en puntos porcentuales; negativo = menos cáncer con arGLP-1. El grupo arGLP-1 cambia en cada "ensayo" (por eso su riesgo va de 2.0 % frente a insulina a 3.0 % frente a metformina), lo que también refleja selección.

OTROS HALLAZGOS	RESULTADO
Tamaño de los grupos	arGLP-1: de 5,835 (frente a metformina) a 18,007 (frente a iSGLT2). Comparadores: de 1,290 (iSGLT2) a 20,445 (metformina)
Balance tras ponderar	La mayoría de las diferencias estandarizadas <0.10. Antes de ponderar, quienes iniciaban insulina tenían complicaciones más avanzadas
DM2 de baja gravedad (3 años)	Diferencia −1.10 puntos frente a insulina y −1.22 frente a sulfonilureas
DM2 de alta gravedad (3 años)	Diferencia a favor del iSGLT2: +1.61 puntos (0.17 a 2.89) a 3 años, con HR 2.07 (0.69–6.25), y +3.10 puntos (1.01 a 5.09) a 5 años; menos de 11 eventos en el grupo iSGLT2 (237 pacientes)

4 Cómo leer estos resultados

- **"Menos cáncer que con insulina" no es "previene el cáncer".** DATO DEL ARTÍCULO La ventaja apareció frente a insulina y sulfonilureas, no frente a metformina, iSGLT2 ni iDPP4. Los autores señalan que la insulina suele iniciarse más tarde en la evolución de la DM2 y que el iSGLT2 se prescribe sobre todo por indicación cardiorrenal; por eso puede quedar diferencia en el control glucémico, el acceso, la vigilancia y el pronóstico. INTERPRETACIÓN Quien inicia insulina suele tener enfermedad más avanzada; con las sulfonilureas pueden influir el control glucémico y la época de prescripción (los autores lo plantean como posibilidad). Si los arGLP-1 tuvieran un efecto antitumoral fuerte, se esperaría verlo también frente a metformina o iDPP4, y no se vio con claridad (HR 0.78 y 0.84, con IC que cruzan el 1). Ojo: la metformina tampoco es un comparador neutro, porque se le atribuye un posible efecto antitumoral.
- **El diseño sí está bien pensado.** DATO DEL ARTÍCULO Usuarios nuevos, comparador activo, tiempo cero en el inicio del fármaco y lavado de 365 días; tras ponderar, la mayoría de las variables quedaron balanceadas. INTERPRETACIÓN Comparar a quien inicia un fármaco con quien inicia otro evita sesgos clásicos: el del usuario prevalente (los que ya toleraron el fármaco) y el de tiempo inmortal. Pero solo balancea lo que está en el expediente; la confusión por indicación que no se registra sigue ahí.
- **Lee la diferencia absoluta, no solo el HR.** DATO DEL ARTÍCULO Frente a insulina, HR 0.62 a 3 años, con una diferencia de 1.25 puntos (2.0 vs. 3.3 %). Frente a sulfonilureas a 5 años, el HR fue significativo (0.75) y la diferencia absoluta no (−0.72; −1.83 a 0.31). INTERPRETACIÓN Un HR de 0.62 suena a "38 % menos", pero en números absolutos equivale, si fuera causal, a un cáncer menos por cada ~80 pacientes que inician un arGLP-1 en lugar de insulina, seguidos 3 años. Cuando el HR y la diferencia absoluta no coinciden, el efecto es más frágil de lo que parece.
- **Muchas estimaciones, ningún ajuste.** DATO DEL ARTÍCULO Cinco comparadores, cuatro estratos (todos y tres de gravedad), dos horizontes y dos medidas, sin ajustar por comparaciones múltiples; los propios autores llaman exploratorios a los análisis por gravedad. INTERPRETACIÓN Son 80 estimaciones, muy correlacionadas entre sí: algunas saldrán "significativas" por azar. Las de insulina y sulfonilureas son coherentes entre sí (global y baja gravedad, a 3 y 5 años). La señal a favor del iSGLT2 en DM2 grave (+1.61 puntos a 3 años y +3.10 a 5 años, con solo 237 pacientes en el grupo iSGLT2, menos de 11 eventos y un HR que cruza el 1) es el ejemplo típico de hallazgo que no hay que sobreinterpretar en ninguna dirección.
- **Poco tiempo para un desenlace oncológico.** DATO DEL ARTÍCULO Muchos usuarios de arGLP-1 iniciaron hace poco, así que las estimaciones a 5 años dependen desproporcionadamente de los primeros usuarios; el cáncer se identificó en el expediente de un solo sistema de salud. INTERPRETACIÓN Tres a cinco años es poco para la latencia de muchos cánceres; un cáncer diagnosticado en otro hospital no se cuenta; y la vigilancia distinta entre grupos (más o menos estudios de detección) puede mover la incidencia sin que cambie la biología.

CONCEPTO CLAVE · EMULACIÓN DE ENSAYO OBJETIVO Y COMPARADOR ACTIVO

Emular un ensayo objetivo es escribir primero el protocolo del ensayo que se haría (quién entra, qué estrategias se comparan, cuándo empieza el seguimiento, qué desenlace) y luego imitarlo con datos observacionales. **Usuario nuevo:** solo entra quien inicia el fármaco, no quien ya lo usaba. **Comparador activo:** se compara con otro tratamiento indicado para lo mismo, no con "no usuarios", para que los grupos se parezcan más. El diseño reduce sesgos, pero **no aleatoriza**: el resultado responde a "arGLP-1 frente a *este* comparador, en *estos* pacientes", y cambia con cada comparador.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Diseño	Usuarios nuevos, comparador activo, tiempo cero alineado, lavado de 365 días; reporte con TARGET.	Confirmado
● Consistencia	Las estimaciones a 3 años y los modelos de Cox concuerdan con las de 5 años; según los autores, esto reduce la incertidumbre, pero no la elimina.	Declarado por los autores
● Un solo sistema de salud	Expediente electrónico retrospectivo de un centro académico de Dallas; posible error de clasificación de la exposición y del desenlace.	Reconocido por los autores
● Confusión residual	Diferencias que persisten pese a la ponderación (inicio más tardío de la insulina, indicación cardiorrenal del iSGLT2).	Reconocido por los autores
● Estratos con pocos eventos	Celdas con menos de 11 eventos suprimidas; categorías de gravedad amplias.	Reconocido por los autores
● Formato breve	Carta de investigación: los cánceres incluidos, los fármacos y los métodos completos están solo en el suplemento.	Interpretación editorial
● Aplicabilidad	Población estadounidense de un centro académico; no separa los arGLP-1 por fármaco ni dosis.	Interpretación editorial

Pregunta de repaso: un paciente con DM2 y obesidad, en metformina, te pide "cambiarse al GLP-1 porque leyó que previene el cáncer". ¿Qué le respondes con este estudio?
Respuesta. Que este estudio comparó iniciar un arGLP-1 contra iniciar metformina (no cambiar de uno a otro), y en esa comparación el riesgo de cáncer relacionado con la obesidad no fue significativamente distinto. La ventaja apareció frente a insulina, que suele iniciarse en enfermedad más avanzada, y frente a sulfonilureas, que según los autores podrían usarse en DM2 peor controlada. Los propios autores dicen que no sirve para elegir el antidiabético por prevenir cáncer. Si un arGLP-1 le conviene, debe ser por sus beneficios ya demostrados (metabólicos, cardiovasculares y renales). Lo que sí aporta es tranquilidad: en el análisis global, frente a ningún comparador hubo más cáncer relacionado con la obesidad; solo en un subgrupo exploratorio (DM2 grave frente a iSGLT2, con pocos eventos) el riesgo fue mayor.

¿Qué aprendí de medicina?

- Frente a metformina, iSGLT2 e iDPP4, iniciar un arGLP-1 no se asoció significativamente a más ni a menos cáncer relacionado con la obesidad.
- Frente a insulina y sulfonilureas hubo menos, posiblemente en parte por quién recibe esos fármacos.
- El antidiabético se elige por sus beneficios demostrados, no para prevenir cáncer.

¿Qué aprendí de investigación?

- El comparador define la pregunta.
- Lee la diferencia absoluta junto al HR.
- Muchas estimaciones sin ajuste = algunas "significativas" por azar.

6 Referencias

1. Hernández-Pérez JG, Abdelgadir O, Torres-Sánchez L, Chen J, Almandoz JP, Cowell LG, et al. GLP-1 receptor agonists and obesity-related cancer by diabetes severity. JAMA Netw Open. 2026;9(11):e2641869. doi:10.1001/jamanetworkopen.2026.41869

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.